

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA



REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES PARA EL
ANÁLISIS DE SEÑALES EEG DURANTE LA MARCHA CON
UN EXOESQUELETO

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Mayo - 2026

AUTOR: Daniel Rosique Egea

DIRECTOR: Eduardo Iañez Martinez

*“The human brain, sculpted by millions of years of evolution, is the sole architect
of the 'human universe'”*

- MIGUEL NICOLELIS

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a ...

Gracias a ...

A ... por ...

RESUMEN

Se utilizarán redes neuronales convolucionales para la detección de patrones cerebrales asociados a la intención de iniciar o detener la marcha en sistemas de asistencia robótica. Este problema resulta clave en el desarrollo de interfaces cerebro-computador aplicadas al control de exoesqueletos, donde la identificación precisa de la intención del usuario es fundamental para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

El objetivo de este trabajo es analizar el rendimiento de diferentes arquitecturas de redes neuronales convolucionales en la clasificación de señales EEG, así como evaluar distintas estrategias de entrenamiento, incluyendo modelos entrenados con datos del mismo día, enfoques acumulativos y técnicas de fine-tuning. Para ello, se emplean registros de EEG previamente adquiridos, aplicando esquemas de validación cruzada y evaluaciones en entornos pseudo-online que simulan condiciones reales de uso.

Los resultados obtenidos permiten comparar el impacto de la arquitectura, el método de entrenamiento y la variabilidad entre usuarios en el rendimiento del sistema, destacando aquellas configuraciones que maximizan la precisión y reducen los falsos positivos. Asimismo, se identifican diferencias significativas entre los distintos enfoques evaluados, lo que proporciona información relevante para el diseño de sistemas más robustos.

Finalmente, este trabajo sienta las bases para la aplicación de estos modelos en escenarios reales, contribuyendo al desarrollo de sistemas de control más fiables en exoesqueletos y otras tecnologías de asistencia basadas en interfaces cerebro-computador.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	III
RESUMEN	V
ÍNDICE DE TABLAS	XI
ÍNDICE DE FIGURAS	XII
ÍNDICE DE CÓDIGOS	XIII
1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Definición del problema	2
1.3. Objetivos a Conseguir	2
2. Estado del Arte	4
2.1. Conceptos Relevantes del Dominio	4
2.1.1. Lesiones y patologías del sistema nervioso central	4
2.1.2. Electroencefalografía (EEG)	6
2.1.3. Interfaces Cerebro-Computador (BCI)	9
2.1.4. Redes neuronales convolucionales	13
2.2. Relación con Proyectos Similares	14
2.2.1. Métodos clásicos	14

2.2.2. Deep Learning aplicado a EEG	15
2.2.3. Aplicaciones en exoesqueletos / rehabilitación	15
2.2.4. Limitaciones actuales	16
2.2.5. Propuesta	16
3. Material y Métodos	17
3.1. Vision General del Sistema	17
3.2. Materiales	19
3.2.1. Hardware	19
3.2.2. Software	19
3.3. Dataset	21
3.3.1. Estructura temporal de los ensayos	22
3.3.2. Preprocesamiento	23
3.4. Modelos utilizados	25
3.4.1. DeepConvNet y ShallowConvNet	25
3.4.2. EEGNet	27
3.5. Metodología experimental	29
3.5.1. Variables del estudio	29
3.5.2. Estrategia de entrenamiento	30
3.5.3. Evaluación	30
3.6. Infraestructura Experimental	30
3.6.1. Diseño de experimentos	31

4. Resultados y Discusión	32
4.1. Tarea Estática	33
4.1.1. Comparación de Global	33
4.1.2. Comparación de Método de Entrenamiento	34
4.1.3. Variabilidad Entre Usuarios	34
4.1.4. Mejor Configuración	35
4.2. Tarea Movimiento	35
4.2.1. Comparación de Global	36
4.2.2. Comparación de Método de Entrenamiento	37
4.2.3. Variabilidad Entre Usuarios	37
4.2.4. Mejor Configuración	38
4.3. Comparación entre tareas	38
5. Conclusiones	39
BIBLIOGRAFÍA	40
ANEXOS	47
A. Primer anexo	47
B. Segundo anexo	48

ÍNDICE DE TABLAS

3.1. Arquitectura DeepConvNet utilizada.	26
3.2. Arquitectura ShallowConvNet utilizada.	27

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1. Esquema de las lesiones medulares en función del area de lesión [9] . . .	5
2.2. Esquema general del funcionamiento de una BCI [26]	12
2.3. Esquema general de una BCI [29]	13
3.1. Pipeline experimental	18
3.2. Estructura temporal de las ventanas EEG utilizadas durante cada ensayo. Adaptado de [34].	23
3.3. Estructura jerárquica de los tensores de entrada y etiquetas utilizados en el modelo.	24
3.4. Arquitectura de EEGNet. las lineas muestran la conexión entre las capas [28].	29
4.1. Comparación general de las distintas arquitecturas y métodos de en- trenamiento en la tarea estática	33
4.2. Variabilidad entre usuarios en la tarea estática	34
4.3. Mejores configuraciones globales en la tarea estática	35
4.4. Comparación general de las distintas arquitecturas y métodos de en- trenamiento en la tarea de movimiento	36
4.5. Variabilidad entre usuarios en la tarea de movimiento	37
4.6. Mejores configuraciones globales en la tarea de movimiento	38
4.7. Comparación de la precisión entre la tarea estática y la de movimiento	38

ÍNDICE DE CÓDIGOS

1. Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones medulares afectan a más de 15 millones de personas a nivel mundial. Estas pueden ser ocasionadas tanto por traumatismos como por causas no traumáticas, incluyendo tumores, enfermedades degenerativas y vasculares, infecciones o defectos congénitos. Como consecuencia, producen una pérdida completa o parcial de las funciones sensoriales y/o motoras por debajo del nivel de la lesión, siendo una de las principales causas de discapacidad de larga duración [1].

Las limitaciones en la movilidad derivadas de estas lesiones dificultan la participación plena en la sociedad. En adultos, esto se traduce en tasas de desempleo superiores al 60 %, mientras que en población infantil se observa una menor continuidad en el sistema educativo [1, 2].

La necesidad de abordar los problemas causados por estas lesiones ha impulsado en los últimos años el desarrollo de nuevas terapias y dispositivos de rehabilitación [3].

En este contexto, las Interfaces Cerebro-Computador (BCIs) han emergido como una tecnología prometedora para la asistencia y rehabilitación de pacientes con discapacidad motora, al permitir la comunicación directa entre la actividad cerebral y dispositivos externos. Estas interfaces emplean principalmente señales electroencefalográficas (EEG) para identificar patrones neuronales asociados a la intención de movimiento [4]. Su aplicación en sistemas de asistencia, como exoesqueletos robóticos, abre nuevas posibilidades para mejorar la autonomía y calidad de vida de personas con lesiones medulares.

Sin embargo, la interpretación de las señales EEG presenta importantes desafíos debido a su baja relación señal-ruido y a la elevada variabilidad entre sujetos y sesiones, lo que dificulta el desarrollo de modelos robustos y generalizables [5].

1.1. Motivación

1.2. Definición del problema

Este trabajo aborda la clasificación de señales EEG registradas durante la imaginación activa de tareas de marcha, con el objetivo de detectar patrones cerebrales relacionados con la intención de caminar o detenerse.

El problema se enmarca en el contexto de las BCI orientadas a aplicaciones de rehabilitación, donde resulta fundamental identificar de forma fiable los estados mentales del usuario a partir de señales cerebrales no invasivas.

Para ello, se pretende evaluar la capacidad de diferentes arquitecturas de redes neuronales para extraer características discriminativas a partir de datos EEG pre-procesados, analizando su rendimiento bajo distintos esquemas de entrenamiento y validación.

Además, se estudia la capacidad de generalización de los modelos, evaluando su robustez frente a la variabilidad entre los sujetos y las diferentes sesiones de registro.

1.3. Objetivos a Conseguir

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el rendimiento de distintas arquitecturas de redes neuronales en la clasificación de la intención de marcha del usuario a partir de señales EEG.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Entrenar y evaluar diferentes arquitecturas de redes neuronales
 - EEGNet
 - DeepConvNet
 - ShallowConvNet

2. Evaluar diferentes métodos de entrenamiento
 - Same-day
 - Acumulativo
 - Fine-tuning
 - Same-day + Fine-tuning
3. Analizar variabilidad entre usuarios y su efecto en el rendimiento de los modelos
4. Evaluar el comportamiento de los modelos en diferentes escenarios de validación, incluyendo validación cruzada y entornos pseudo-online.

2. Estado del Arte

La rehabilitación de los pacientes tras una lesión medular es un tema peliagudo, que conlleva un de complicaciones, ya que la rehabilitación de estos pacientes requiere de un gran esfuerzo físico y psicológico Por estos motivos, en los últimos años, un enfoque que está ganando tracción es el de las interfaces cerebro-computador (BCI), que permiten una rehabilitación asistida más eficiente y con una menor carga al paciente y al profesional [XXX].

Este capítulo trata de introducir los fundamentos que sustentan este trabajo, al igual que se ahonda en el estado actual de las técnicas de Interfaz Cerebro-Computador (BCI) y Electroencephalography (EEG) y sus aplicaciones, para de esta manera poder entender el problema que se pretende resolver y la solución que se pretende dar.

2.1. Conceptos Relevantes del Dominio

Aquí debería poner algooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Nose el qué

2.1.1. Lesiones y patologías del sistema nervioso central

El sistema nervioso central (CNS), encargado de la planificación, iniciación y modulación del movimiento, comprende estructuras como la corteza cerebral, el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal. A través de estas estructuras, el CNS procesa la información sensorial y genera impulsos nerviosos que son transmitidos a los músculos para producir movimiento [6].

Las lesiones o patologías que afectan al CNS pueden dañar tanto las neuronas como las vías de comunicación entre ellas, alterando la transmisión de señales motoras y sensitivas. Como consecuencia, pueden aparecer deficiencias motoras, pérdida de sensibilidad, alteraciones del equilibrio o dificultades en la coordinación del movimiento [6].

Entre las lesiones más relevantes se encuentran las lesiones medulares (SCI), producidas por causas traumáticas o no traumáticas que dañan parcial o totalmente la médula espinal. Este daño interrumpe la transmisión de señales nerviosas entre el cerebro y las regiones corporales situadas por debajo de la lesión. Los síntomas dependen tanto de la localización como de la gravedad del daño. Las lesiones cervicales pueden provocar tetraplegia, mientras que lesiones en regiones más bajas suelen derivar en paraplegia [7, 8].

En la figura 2.1 se puede ver un esquema de las lesiones medulares en función del area de lesión.

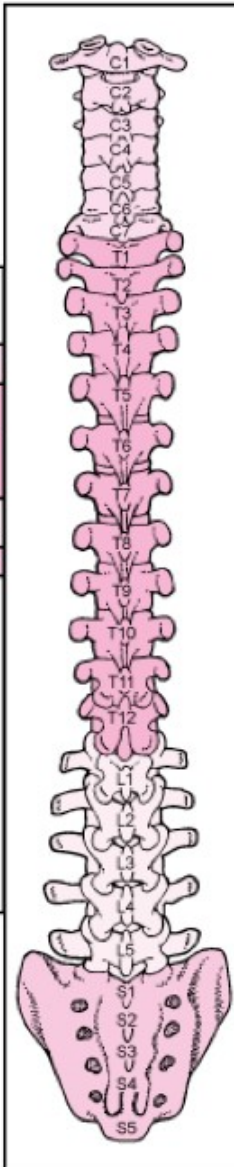
		Nivel de la lesión	Efecto*
C T L S		C E R V I C A L	
		Entre C2 y C5	Parálisis de algunos o todos los músculos utilizados para respirar y todos los músculos de brazos y piernas. En general mortal, a menos que se use un ventilador.
		Entre C5 y C6	Parálisis de las piernas, tronco, mano y muñeca. Debilidad de los músculos que mueven el hombro y el codo.
		Entre C6 y C7	Parálisis de las piernas, el tronco y parte de las muñecas y manos. Movimiento normal de hombros y codos.
		Entre C7 y C8	Parálisis de las piernas, el tronco y las manos.
		T O R Á C I C A	
		C8 a T1	Parálisis de piernas y tronco. Debilidad de los músculos que mueven dedos y manos. Síndrome de Horner (con párpado caído, pupila constreñida y sudoración reducida en un lado de la cara). Posiblemente movimiento normal de hombros y codos.
		T2 a T4	Parálisis de piernas y tronco. Pérdida de la sensibilidad debajo de los pezones. Movimiento normal de hombros y codos.
		T5 a T8	Parálisis de las piernas y la parte inferior del tronco. Pérdida de la sensibilidad debajo de la caja torácica.
		T9 a T11	Parálisis de las piernas. Pérdida de la sensibilidad debajo del ombligo.
		L U M B A R	
		T11 a L1	Parálisis y pérdida de sensibilidad en caderas y piernas.
		L2 a S2	Diversos patrones de debilidad y entumecimiento, según el nivel concreto de la lesión.
S A C R O			
S3 a S5		Entumecimiento en el perineo.	
*Las lesiones graves pueden causar la pérdida del control de la vejiga y el intestino en cualquier nivel de la médula espinal.			

Figura 2.1: Esquema de las lesiones medulares en función del area de lesión [9]

Otra de las principales patologías del CNS son los accidentes cerebrovasculares o ictus. Estos pueden clasificarse en hemorrágicos, cuando se produce la rotura de un vaso sanguíneo cerebral, o isquémicos, cuando una obstrucción reduce o bloquea el flujo sanguíneo. En ambos casos se produce daño neuronal debido a la falta de oxígeno y nutrientes en el tejido cerebral afectado [10]. Los ictus representan una de las principales causas de discapacidad motora adquirida y mortalidad a nivel mundial [6, 10, 11].

A pesar de la gravedad de estas lesiones, existe un potencial de rehabilitación en la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del CNS para modificar su estructura y funcionamiento, así como crear nuevas conexiones neuronales en respuesta a estímulos externos o internos [6, 12]. La rehabilitación neurológica busca potenciar esta reorganización funcional de las áreas cerebrales no afectadas [13], creando nuevas conexiones mediante la repetición de tareas.

La rehabilitación constituye un proceso complejo que requiere un enfoque multidisciplinar y tratamientos personalizados. Aunque parte de la recuperación motora suele producirse durante los primeros meses tras la lesión, muchos pacientes continúan presentando secuelas permanentes en fases crónicas [11]. En estos casos, las tecnologías de asistencia, incluyendo los sistemas basados en interfaces cerebro-computadora (BCI), representan una herramienta prometedora para mejorar la autonomía y la interacción con el entorno.

2.1.2. Electroencefalografía (EEG)

La electroencefalografía (EEG) consiste en la captación de la actividad eléctrica cerebral generada por la comunicación entre neuronas. Estas señales se registran mediante electrodos no invasivos colocados sobre el cuero cabelludo y son posteriormente amplificadas y representadas en función del tiempo [14, 15].

Dentro de estas señales se encuentran respuestas neuronales asociadas a distintos tipos de eventos (sensoriales, cognitivos y motores) conocidas como potenciales relacionados con eventos (ERP), así como aquellas asociadas a la imaginación motora

(MI) [14, 16].

Es común realizar una separación de estas señales en función de su frecuencia, ya que se ha demostrado que distintas bandas de frecuencia se corresponden con estados mentales concretos [15, 17].

- **Delta** (<4 Hz): Ubicadas en la región frontal en adultos y posterior en los niños. Se asocian principalmente al sueño, siendo también frecuentes en niños y en tareas de atención sostenida.
- **Theta** (4–7 Hz): Predominan en las regiones parietal y temporal en niños. En adultos, aparecen durante algunas fases del sueño o en estados de estrés
- **Alpha** (8–13 Hz): Se localizan en la región occipital. Se asocian a estados de relajación con los ojos cerrados, disminuyendo durante la concentración y el sueño.
- **Beta** (13–30 Hz): Son detectadas en los lóbulos frontal y parietal y presentan una distribución relativamente simétrica. Aparecen en tareas de calma activa con los ojos abiertos. Pero también pueden aparecer durante actividad mental intensa o situaciones de estrés.
- **Gamma** (>30 Hz): Se han relacionado con actividad en la región somatosensorial durante tareas de procesamiento multisensorial y en procesos cognitivos complejos, como la memoria.
- **Mu** (8–12 Hz): Se localizan en el córtex sensoriomotor y se asocian a la actividad de este sistema en reposo.

El análisis de señales EEG es una herramienta muy potente que permite revelar información sobre la actividad cerebral de un individuo, teniendo muchas aplicaciones en neurociencia y en BCI [18].

Entre las principales ventajas del uso de EEG se encuentran [14, 15, 19, 20]:

- **Alta resolución temporal:** Permite registrar cambios en la actividad cerebral en el rango de milisegundos.

- **Medición directa de actividad eléctrica:** A diferencia de otras técnicas que estiman la actividad cerebral de forma indirecta mediante cambios en los niveles de oxígeno en sangre, las señales EEG registran directamente la actividad eléctrica generada por poblaciones neuronales.
- **Carácter no invasivo:** La señal puede registrarse mediante electrodos colocados sobre el cuero cabelludo, sin necesidad de procedimientos quirúrgicos. Esto reduce el riesgo de sufrir complicaciones durante la captura de la señal y las molestias a los pacientes.
- **Bajo coste relativo:** En comparación con otras técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, los sistemas EEG suelen ser más accesibles y fáciles de utilizar.

Algunas de las desventajas que convierten a estas señales en difíciles de analizar son las siguientes [14, 21, 22]:

- **Baja resolución espacial:** Las señales EEG no permiten localizar con precisión la fuente de actividad cerebral, ya que representan una media de múltiples fuentes de actividad neuronales.
- **Variabilidad inter-sujeto e intra-sujeto:** Existe una gran variabilidad en las señales EEG entre diferentes individuos, lo que dificulta la observación de patrones en ellas. A su vez, las propiedades estadísticas de las señales pueden variar a lo largo del tiempo, incluso para un mismo sujeto y tarea.
- **Ruido:** Las señales EEG son altamente susceptibles a artefactos, como el movimiento, la actividad muscular (EMG) o interferencias externas. Además, la amplitud de las señales EEG es muy baja en comparación con el ruido presente, lo que exige un preprocesado avanzado para eliminar el ruido y mejorar la calidad de las señales.

Estas limitaciones justifican el uso de técnicas avanzadas de procesamiento y aprendizaje automático. En los últimos años el uso de modelos de aprendizaje profundo

(deep learning) ha supuesto un avance significativo, facilitando el desarrollo de aplicaciones más prácticas y reduciendo la dependencia de procesamiento manual por parte de expertos [18].

Potenciales relacionados a eventos (ERP)

Intención de movimiento (MI)

2.1.3. Interfaces Cerebro-Computador (BCI)

Definición → 1 párrafo Funcionamiento + figura → 2 párrafos Aplicaciones → 1 párrafo Tipos → 1 párrafo

Una interfaz cerebro-computador (BCI) es un sistema capaz de adquirir señales cerebrales, procesarlas y traducirlas en comandos de control para un dispositivo externo, sin necesidad de utilizar las vías motoras convencionales [23, 24]. Inicialmente, las aplicaciones de estas interfaces se centraban en la rehabilitación y asistencia médica para la recuperación de capacidades motoras de pacientes con lesiones motoras[24, 25].

El esquema general de las BCI se representa en la figura 2.2. En él se observan las distintas fases de las que se compone el sistema de control. El primer paso es la adquisición de la señal cerebral, en el cual se registran los potenciales mediante electrodos posicionados en distintas zonas de la cabeza[26].

Después de la adquisición de la señal, se realiza un paso intermedio en el cual se eliminan posibles artefactos de la señal, como las interferencias de red o las componentes de ruido.

A continuación estas señales son procesadas para extraer las características específicas sujeto de análisis. Es procesamiento incluye uno o varios métodos de filtrado, como el análisis espectral, la medición de la amplitud de voltajes, etc. Este

Se trata de una tecnología capaz de ayudar en la rehabilitación de pacientes con lesiones motoras, al igual que permite reemplazar las funciones de los miembros

dañados por la lesión en pacientes crónicos[24].

The immediate goal is to provide these users, who may be completely paralyzed, or ‘locked in’, with basic communication capabilities so that they can express their wishes to caregivers or even operate word processing programs or neuroprostheses[27].

A BCI output might replace natural output that has been lost as a result of injury or disease. For example, a person who can no longer speak might use a BCI to type words that are then spoken by a speech synthesizer. Or a person who has lost limb control might use a BCI to operate a motorized wheelchair. In these examples the BCI outputs replace lost natural outputs. A BCI output might restore lost natural output. For example, a person with spinal cord injury whose arms and hands are paralyzed might use a BCI to stimulate the paralyzed muscles via implanted electrodes so that the muscles move the limbs. Or a person who has lost bladder function due to multiple sclerosis might use a BCI to stimulate the peripheral nerves that control the bladder, thus enabling urination. In these examples, the BCI outputs restore the natural outputs. A BCI output might enhance natural CNS output. For example, a person performing a task that requires continuous attention over a prolonged period (e.g., driving a vehicle or serving as a sentry) might use a BCI that detects the brain activity preceding lapses in attention and then provides an output (e.g., a sound) that alerts the person and restores attention. By preventing the attentional lapses that periodically impair natural CNS output (and might cause traffic accidents), the BCI enhances the natural output. A BCI output might supplement natural CNS output. For example, a person who is controlling the position of a computer cursor with a hand-operated joystick might use a BCI to select items that the cursor reaches. Or a person might use a BCI to control a third (i.e., robotic) arm and hand. In these cases, the BCI supplements natural neuromuscular output with an additional, artificial output [26].

El funcionamiento general de una BMI está representado en la Figura 4. El primer paso, es la adquisición de los datos, donde las señales cerebrales del sujeto son registradas mediante electrodos, invasivos o no invasivos, ubicados en su cabeza y transformadas a señales digitales a través de amplificadores. El segundo paso, es el

procesamiento de las señales registradas aplicándoles una serie de filtros para eliminar ruido y otros artefactos, como las interferencias de red. Una vez acondicionada la señal, el tercer paso es extraer características de los trozos de señal y se seleccionan aquellas que aportan información relevante para diferenciar la tarea en el clasificador. El siguiente paso es clasificar los ritmos motores captados por los electrodos según los potenciales evocados o intenciones motoras que puedan contener. En función de la clasificación de la señal, se producen distintos comandos de control en otros dispositivos, como pueden ser ordenadores, robots domésticos o exoesqueletos, entre otros. Tras ejecutar el comando, el dispositivo que lo ha ejecutado produce una respuesta que es transmitida al sujeto. Generalmente, los BMI son sistemas de bucle cerrado donde el sujeto es realimentado con información acerca del resultado de las órdenes enviadas al dispositivo. La respuesta recibida varía dependiendo del dispositivo al que está vinculado la BMI. Cuando está conectada a un ordenador recibirá un feedback visual. En cambio, cuando se trate de un exoesqueleto, la respuesta será a través de un movimiento en la extremidad del sujeto

En primer lugar, los BMI invasivos consisten en introducir los electrodos en la región intracortical de la cabeza. Este procedimiento implica una operación donde se retira un trozo de cráneo para implantar los electrodos en el cerebro y pinchar las neuronas. La principal ventaja de esta técnica es que la adquisición de la señal se hace directamente sobre las neuronas que producen las señales deseadas. Por tanto, la señal tiene una gran resolución espacial y temporal con escaso ruido. Sin embargo, esta técnica presenta una importante desventaja que es exponer al paciente a una intervención quirúrgica compleja y a electrodos en el interior de su cuerpo, que tarde o temprano deben ser o bien reemplazados, o bien retirados. En segundo lugar, los BMI parcialmente invasivos colocan los electrodos sobre la superficie del cerebro. Esta técnica es muy similar a la anterior, pero en este caso la captación se realiza por electrocorticografía (ECoG) [15]. Este método presenta una resolución espacial y temporal medias, ya que eliminan parte de los artefactos causados por la piel y el hueso, pero las señales de las regiones más profundas del cerebro siguen presentando una pequeña cantidad de ruido espacial. Por el contrario, la principal desventaja que presentan es exactamente la misma que en las BMI invasivas:

la intervención quirúrgica y sus riesgos. Adicionalmente, ambas técnicas implican un elevado coste. En tercer lugar, los BMI no invasivos ubican los electrodos en la superficie de la cabeza, sobre el cuero cabelludo. Por tanto, se elimina el problema de someter al paciente a la cirugía y se reduce el coste. Además, los electrodos son portables, normalmente están agrupados en un casco, y se puede colocar en distintos entornos, no sólo en un quirófano. Sin embargo, el tiempo de colocación de los electrodos es muy elevado. Asimismo, la desventaja de eliminar los electrodos no invasivos es que se pierde resolución espacial, especialmente al realizar la captación por EEG o MEG, donde algunos electrodos registran señales de múltiples regiones. No obstante, este método no pierde la resolución temporal

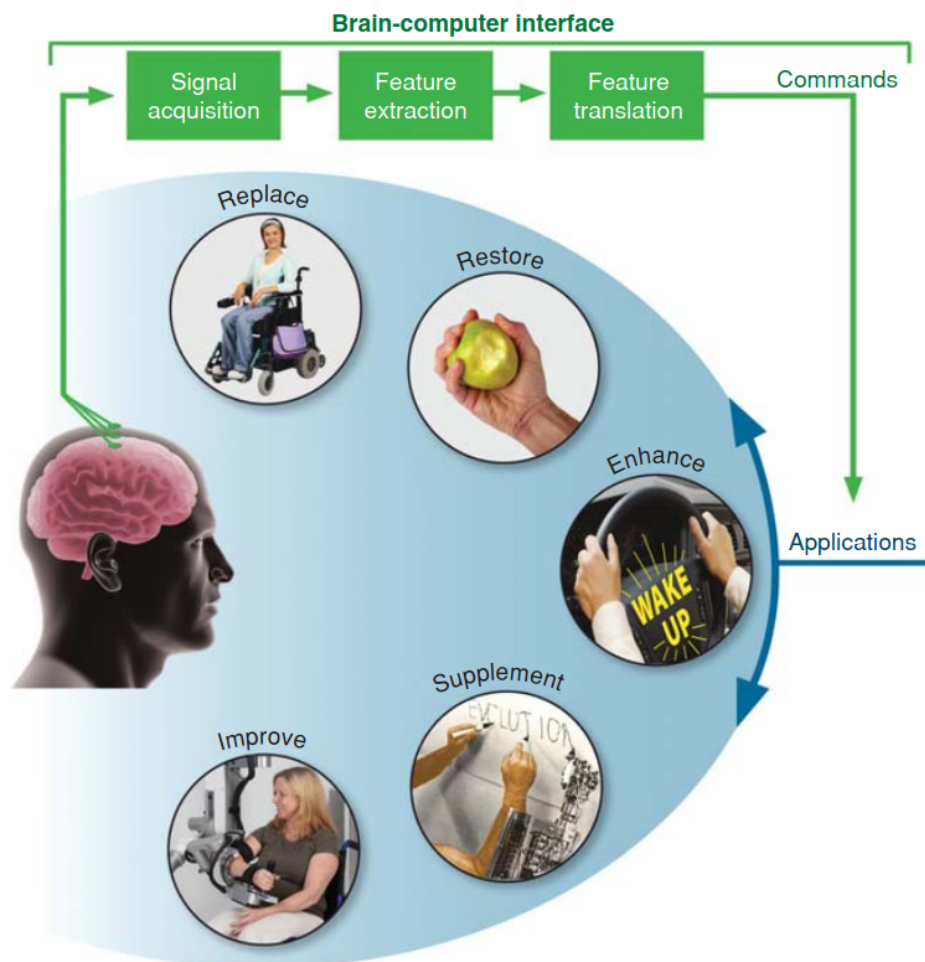


Figura 2.2: Esquema general del funcionamiento de una BCI [26]

SACAR COSAS DE [28]

Como tecnología asistiva Cuando el daño motor de un individuo ya es crónico, estas interfaces se pueden utilizar como herramienta de comunicación, para controlar

miembros artificiales (sustitución motora) o incluso para el ocio

Sustitución motora

- El concepto de movilidad asistiva se puede encuadrar dentro de la sustitución motora
- Un ejemplo es el uso de sillas de ruedas controladas por BCI
- La silla de ruedas, es considerada, por muchos usuarios como parte de su propio cuerpo (embodiment) y funciona de forma equivalente a una prótesis

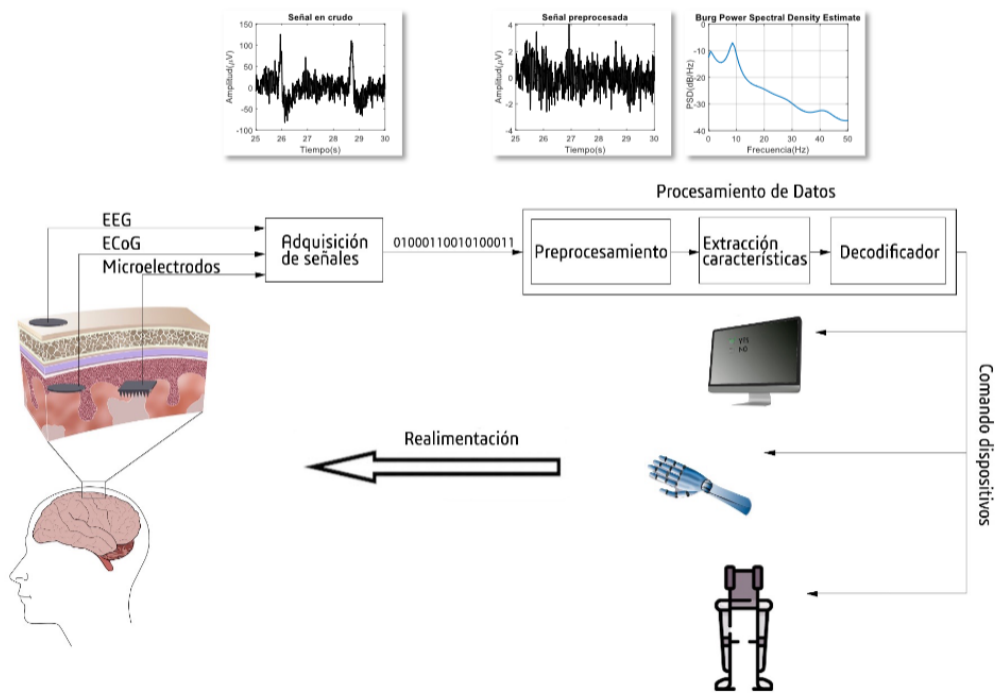


Figura 2.3: Esquema general de una BCI [29]

2.1.4. Redes neuronales convolucionales

A convolution neural network (CNN) is among the most popular and successful deep learning methods for EEG decoding. CNNs are designed for signal processing and analysis, especially for those contexts that provide spatial information. The convolutional layer is a fundamental building block of CNN that extracts features by sliding small filters across the input. Each filter is equipped with learnable weights designed to detect specific patterns, and the aggregation of multiple filters results in the creation of a feature map. During the training of a CNN, backpropagation is adopted to calculate the gradients of the loss function with respect to the weights

of the network, allowing for weight updates that minimize the overall loss. When adopted into EEG decoding, CNNs are generally initiated with an input layer that accepts the pre-processed EEG data. [30]

Then, the CNN extracts spectral and spatial features by deploying a spatial convolution layer along the channel dimension and a temporal convolution layer along the sample dimension. After this step, several layers will be followed to project the feature into higher dimensions. Between two convolutional layers, there always exists one pooling layer to reduce the parameter dimension and eliminate overfitting. In the final phase, the fully connected layer serves as a decision-making layer, mapping the high-level representations to the specific classes related to the decoding task.[30]

LeCun et al. [2015], Goodfellow et al. [2016], and Schmidhuber [2015]. [20]

2.2. Relación con Proyectos Similares

Estructura muy clara:

2.2.1. Métodos clásicos

Esto investigarlo más y ponerlo bonito Barachant et al. [22] introduced Riemannian geometry for BCI with an LDA classifier to successfully classify EEG covariance matrices. Lotte and Guan [23] introduced a unifying theoretical framework for regularizing the CSP and compared it with 10 other regularized versions of the CSP algorithm. Another feature extraction algorithm, considering the CSP, is the Filter Bank Common Spatial Pattern (FBCSP) with a Naïve Bayesian Parzen Window classifier [31]

The winner of the BCI discipline of the Cybathlon competitions used the power spectral density of the EEG signals as a feature [13], [19] with a Gaussian classifier.

- LDA, SVM

- Features manuales
- Limitaciones

2.2.2. Deep Learning aplicado a EEG

Before neural networks, scientists intended to investigate and develop hand-crafted feature extraction methods combined with simple classification algorithms. [31] With the introduction of the Deep and Shallow ConvNets, a new trend started in BCI development. The focus had been shifted from hand-crafted features to creating neural networks which not just classify the signal but also include the feature extraction step. Lawhern et al. [25] introduced the EEGNet, which was inspired by former neural networks that were designed for EEG signal processing, including MI-based BCIs [1], [26]–[28]. It was demonstrated that EEGNet makes a similar feature extraction as the FBCSP[31] Other publications outside the EEGNet family [43]–[49] highlight the importance of neural network-based BCI research. CNNs (EEGNet, DeepConvNet...)

Qué han conseguido

Problemas abiertos:

generalización

dependencia del usuario

2.2.3. Aplicaciones en exoesqueletos / rehabilitación

Uso de BCI para control

Problema clave:

detección fiable de intención

2.2.4. Limitaciones actuales

variabilidad entre sujetos

necesidad de recalibración

falsos positivos peligrosos

falta de evaluación en escenarios realistas

2.2.5. Propuesta

En este contexto, este trabajo se centra en...

Aquí conectas directamente con tu TFM:

comparación de métodos de entrenamiento

evaluación pseudo-online

análisis sistemático

3. Material y Métodos

3.1. Vision General del Sistema

Se ha definido un pipeline de ejecución que permite realizar múltiples experimentos de forma iterativa y automatizada. Este pipeline está compuesto por distintos módulos encargados de gestionar el preprocesamiento de los datos, la configuración de los modelos, el entrenamiento y la evaluación de los mismos.

Con el objetivo de facilitar la reproducibilidad y la exploración sistemática de parámetros, el código se ha estructurado como un microframework que permite modificar de forma sencilla las variables de estudio, así como controlar la ejecución de los experimentos. Este enfoque ha resultado especialmente útil dado el elevado número de ejecuciones.

Para organizar la ejecución, se ha definido una estructura jerárquica en tres niveles:

- **Experimento:** nivel superior que agrupa el conjunto completo de configuraciones evaluadas. Un experimento consiste en la ejecución sistemática de múltiples combinaciones de parámetros.
- **Iteración:** cada una de las ejecuciones individuales del pipeline dentro de un experimento, asociada a una combinación específica de parámetros (arquitectura, método de entrenamiento y tipo de tarea).
- **Entrenamiento:** nivel más bajo de la jerarquía, correspondiente al entrenamiento y evaluación de un modelo para un usuario y sesión concretos dentro de una iteración.

De este modo, cada experimento está compuesto por múltiples iteraciones, y cada iteración incluye varios entrenamientos, uno por cada usuario y sesión del dataset. Los experimentos se definen mediante la combinación de distintos parámetros, entre los que destacan el tipo de tarea, la arquitectura del modelo y el método de entrenamiento. Para cada combinación se ejecuta una iteración independiente

En cada iteración, el sistema inicializa los parámetros de entrenamiento y carga el conjunto de datos correspondiente al tipo de tarea. A continuación, se ejecuta el método de entrenamiento seleccionado, en el que se itera sobre los distintos usuarios y sesiones disponibles en el dataset. Para cada caso, se inicializa el modelo, se realiza el entrenamiento y se evalúa su rendimiento.

Finalmente, los resultados obtenidos, junto con los parámetros utilizados, se almacenan de forma estructurada, permitiendo su posterior análisis.

Este proceso permite realizar un estudio posterior de los resultados obtenidos por cada combinación de parámetros definida.

La Figura 3.1 resume la organización jerárquica del pipeline experimental.

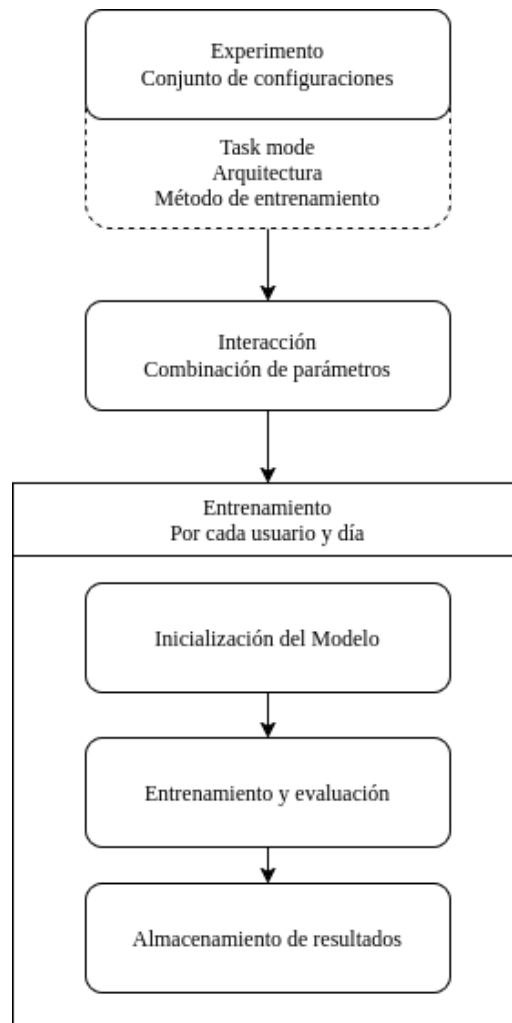


Figura 3.1: Pipeline experimental

3.2. Materiales

3.2.1. Hardware

Para ejecutar los distintos entrenamientos se ha utilizado un ordenador con las siguientes características:

- **CPU:** Intel Core i9-14900HX
- **RAM:** 31 GiB
- **GPU:** NVIDIA GeForce RTX 4060
- **GPU RAM:** 8 GiB

Estas características han resultado suficientes para completar los experimentos planteados sin limitaciones críticas. El tiempo medio de entrenamiento por iteración ha sido aproximadamente 40 minutos, dependiendo de la configuración del modelo y de los parámetros de entrenamiento.

El tiempo total de cómputo se estima mediante:

$$\text{Tiempo total (h)} = \frac{N_{\text{iteraciones}} \times t_{\text{iteración}}}{60}$$

Donde $N_{\text{iteraciones}} = 1917$ y $t_{\text{iteración}} = 40\text{minutos}$, resultando en un tiempo total aproximado de 766.8 horas ($\approx 31\text{días}$).

El uso de hardware con mayores prestaciones permitiría reducir significativamente el tiempo total de entrenamiento y facilitar la realización de un mayor número de experimentos.

3.2.2. Software

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado una infraestructura basada en herramientas ampliamente empleadas en el ámbito del aprendizaje automático y la

ingeniería de software.

Como lenguaje de programación principal se ha utilizado Python¹, debido a su amplio ecosistema de librerías científicas y de aprendizaje automático, así como su facilidad de integración con frameworks de alto nivel.

Para la construcción y entrenamiento de los modelos se han utilizado TensorFlow² y Keras³, frameworks de aprendizaje profundo que permiten definir, entrenar y evaluar redes neuronales de forma eficiente. Keras se ha empleado como interfaz de alto nivel sobre TensorFlow, facilitando la experimentación rápida con distintas arquitecturas.

Durante las etapas iniciales del proyecto se empleó Jupyter Notebook⁴ para la realización de pruebas exploratorias y la visualización preliminar de resultados. Sin embargo, su uso fue descartado en fases posteriores debido a la dificultad para mantener una estructura de código modular y escalable en experimentos de mayor complejidad.

Posteriormente, se adoptó Visual Studio Code⁵ como entorno de desarrollo principal, debido a su capacidad para gestionar múltiples tipos de archivos y su integración con herramientas de desarrollo. Se utilizaron extensiones específicas para Python, Jupyter y GitHub, permitiendo un flujo de trabajo unificado.

Como sistema de control de versiones se ha utilizado GitHub⁶, que facilita la gestión del código, el seguimiento de cambios y la colaboración con el tutor del proyecto. Además, permite la sincronización del repositorio entre distintos dispositivos de forma eficiente.

Para la visualización de resultados se ha utilizado Vega-Altair⁷, una librería de visualización estadística declarativa enfocada en la simplicidad, eficiencia y legibilidad. A diferencia de enfoques imperativos como Matplotlib, Altair permite definir visualizaciones de forma estructurada y reproducible, enfocándose en lo que se quiere

¹<https://www.python.org/>

²<https://www.tensorflow.org/>

³<https://keras.io/>

⁴<https://jupyter.org/>

⁵<https://code.visualstudio.com/>

⁶<https://github.com/>

⁷<https://altair-viz.github.io/>

observar en lugar de en los detalles de la implementación. Esto conduce a un código más limpio y legible [32]

Como gestor de base de datos se ha utilizado DuckDB⁸, un sistema de bases de datos analítico embebido que permite realizar consultas SQL de forma eficiente directamente sobre archivos locales. Su integración con Python y su alto rendimiento lo hacen especialmente adecuado para el procesamiento de grandes volúmenes de resultados experimentales [33].

Todas estas herramientas han sido integradas en un flujo de trabajo unificado orientado a la ejecución reproducible de experimentos.

3.3. Dataset

El dataset utilizado en este trabajo está compuesto por registros EEG obtenidos de 5 sujetos a lo largo de 5 días consecutivos de adquisición. Para cada día se realizaron 11 ensayos (*trials*), y cada ensayo fue segmentado en 56 ventanas temporales, obteniendo un total de:

$$5 \times 5 \times 11 \times 56 = 15400 \text{ ventanas}$$

Cada ventana contiene 400 muestras adquiridas a una frecuencia de muestreo de 200 Hz, lo que equivale a 2 segundos de señal EEG.

Las Muestras a su vez incluyen la señal de 27 canales EEG. Los 27 canales corresponden a los electrodos seleccionados para la adquisición de la señal. Por tanto, cada instancia del dataset puede interpretarse como una matriz de tamaño 27×400 , donde cada fila representa la evolución temporal de un canal EEG durante la ventana analizada.

Los 27 canales EEG utilizados fueron: F3, FZ, FC1, FCZ, C1, CZ, CP1, CPZ, FC5, FC3, C5, C3, CP5, CP3, P3, PZ, F4, FC2, FC4, FC6, C2, C4, CP2, CP4, C6, CP6

⁸<https://duckdb.org/>

y P4. Estos electrodos se colocaron siguiendo el sistema internacional 10-10 [34].

Los datos originales se encuentran distribuidos en cuatro ficheros MATLAB diferenciados según la tarea experimental:

	Labels	Training
Static	labels_static_data.mat	training_static_data.mat
Motion	labels_motion_data.mat	training_motion_data.mat

Los ficheros de etiquetas contienen la intención de movimiento asociada a cada ventana temporal, mientras que los ficheros de entrenamiento almacenan las señales EEG correspondientes.

Las etiquetas presentan una dimensión $(15400, 1)$, mientras que los datos EEG poseen una estructura $(15400, 27, 400)$, donde:

- $N = 15400$ corresponde al número total de ventanas,
- $C = 27$ representa el número de canales EEG,
- $S = 400$ indica el número de muestras temporales por ventana.

3.3.1. Estructura temporal de los ensayos

Cada *trial* corresponde a una secuencia estructurada de tareas mentales compuesta por tres etapas:

- 14 ventanas de relajación inicial (7s),
- 28 ventanas de imaginación motora de la marcha (14s),
- 14 ventanas finales de relajación (7s).

Las ventanas se organizan secuencialmente dentro de cada ensayo con un desplazamiento temporal de 0.5s entre ventanas consecutivas.

Antes de cada tarea mental se le da una instrucción al usuario, esta instrucción puede alterar el clasificador, ya que no corresponde con ninguna tarea mental definida, por lo que se eliminan durante el preprocesamiento.

Adicionalmente, antes de cada ensayo se incluía un periodo inicial de duración aleatoria en el que el sujeto realizaba una tarea mental distinta. El objetivo de este periodo es el de reducir artefactos y ruido en la señal (convergencia de filtros). Este segmento fue eliminado durante el procesamiento previo del dataset.

Durante las sesiones experimentales los sujetos alternaban entre las tareas de imaginación estática (*static*) y de imaginación motora (*motion*) con el objetivo de reducir la fatiga y evitar la monotonía durante la adquisición.

La Figura 3.2 muestra un esquema de la segmentación temporal empleada durante los ensayos.

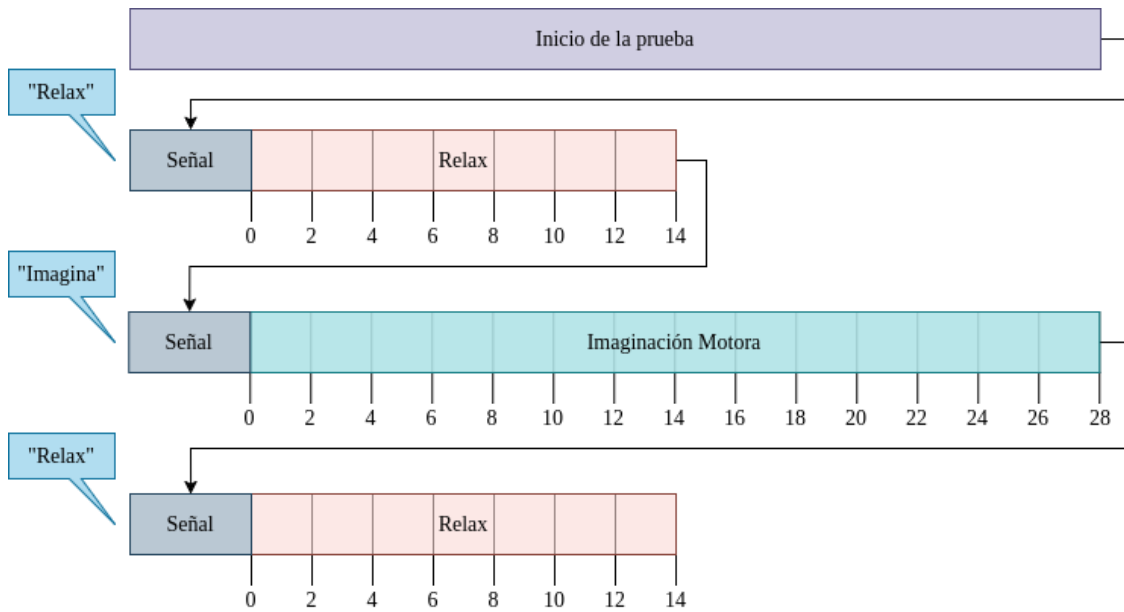


Figura 3.2: Estructura temporal de las ventanas EEG utilizadas durante cada ensayo. Adaptado de [34].

3.3.2. Preprocesamiento

Previo al estudio, las señales EEG fueron sometidas a una etapa de preprocesamiento con el objetivo de reducir el ruido y conservar únicamente los componentes frecuenciales relevantes para las tareas mentales objetivo.

En concreto, a cada canal EEG se le aplicó un filtro paso banda entre 8 y 40 Hz. Este rango frecuencial incluye principalmente las bandas μ (8–13 Hz) y β (13–30 Hz), ampliamente utilizadas en aplicaciones de BCI basadas en imaginación motora debido a su relación con la actividad cortical motora [35].

A partir de los datos preprocesados, se ha realizado una reorganización estructural de los mismos con el objetivo de facilitar su uso en los modelos propuestos. En concreto, los datos se han reestructurado en tensores de seis dimensiones:

Con el objetivo de facilitar el entrenamiento y evaluación de los modelos propuestos, los datos fueron reorganizados en tensores que preservan la jerarquía original del dataset.

Los tensores de entrada y etiquetas presentan las siguientes dimensiones:

Input tensor shape: (5, 5, 11, 56, 27, 400)						
Dim.	1	2	3	4	5	6
Name	Users	Days	Trials	Windows	Channels	Samples
Size	5	5	11	56	27	400
Labels tensor shape: (5, 5, 11, 56, 1)						
Dim.	1	2	3	4	5	
Name	Users	Days	Trials	Windows	Label	
Size	5	5	11	56	1	

Figura 3.3: Estructura jerárquica de los tensores de entrada y etiquetas utilizados en el modelo.

Esta organización permite mantener la coherencia temporal y experimental de las muestras durante las distintas fases de entrenamiento y evaluación.

En cuanto a la partición de los datos, se ha realizado una división entrenamiento-test con una proporción del 70 % y 30 %, respectivamente. Esta separación se ha llevado a cabo a nivel de *trial*, evitando separar ventanas pertenecientes al mismo ensayo entre ambos conjuntos.

La selección del conjunto de test no se ha realizado de forma aleatoria, sino utilizando los últimos *trials* de cada sujeto y día. Esta decisión se basa en la hipótesis de que

los sujetos presentan una mejora progresiva en el control de la imaginación motora a lo largo de la sesión, lo que permite evaluar el modelo en condiciones más estables.

Finalmente, no se aplicaron técnicas adicionales de filtrado o procesamiento sobre las señales EEG.

3.4. Modelos utilizados

Se van a definir las arquitecturas de los modelos usados en el estudio y a justificar su elección.

3.4.1. DeepConvNet y ShallowConvNet

Las arquitecturas DeepConvNet y ShallowConvNet, propuestas por Schirrmeister et al. [20], fueron de los primeros modelos convolucionales en lograr un impacto significativo en la clasificación de señales EEG. Desde entonces, estas arquitecturas han sido ampliamente utilizadas como referencia en numerosos trabajos relacionados con interfaces cerebro-computador y Deep Learning aplicado a EEG [31].

La arquitectura DeepConvNet está formada por cuatro bloques convolucionales seguidos de operaciones de *max-pooling* y una capa final de clasificación *softmax*. El primer bloque convolucional fue diseñado específicamente para adaptarse a las características de las señales EEG, las cuales presentan un número elevado de canales de entrada correspondientes a los distintos electrodos. Para ello, el bloque es separado en dos capas. La primera realiza un filtrado temporal sobre la señal de cada canal, permitiendo extraer patrones relacionados con las frecuencias presentes en el EEG. Posteriormente, la segunda convolución aplica un filtrado espacial combinando la información obtenida en la primera capa. Esta separación entre convolución temporal y espacial actúa además como una forma implícita de regularización, forzando a la red a aprender transformaciones más estructuradas [20].

Block	Layer	# filters	Size	# params	Output
1	Input	–	–	0	(27, 400, 1)
	Conv2D	25	(1, 8)	225	(27, 393, 25)
	Conv2D	25	(27, 1)	16900	(1, 393, 25)
	BatchNorm	–	–	100	(1, 393, 25)
	Activation	–	ELU	0	(1, 393, 25)
	MaxPool2D	–	(1, 2)	0	(1, 196, 25)
	Dropout	–	–	0	(1, 196, 25)
2	Conv2D	50	(1, 8)	10050	(1, 189, 50)
	BatchNorm	–	–	200	(1, 189, 50)
	Activation	–	ELU	0	(1, 189, 50)
	MaxPool2D	–	(1, 2)	0	(1, 94, 50)
	Dropout	–	–	0	(1, 94, 50)
3	Conv2D	100	(1, 8)	40100	(1, 87, 100)
	BatchNorm	–	–	400	(1, 87, 100)
	Activation	–	ELU	0	(1, 87, 100)
	MaxPool2D	–	(1, 2)	0	(1, 43, 100)
	Dropout	–	–	0	(1, 43, 100)
4	Conv2D	200	(1, 8)	160200	(1, 36, 200)
	BatchNorm	–	–	800	(1, 36, 200)
	Activation	–	ELU	0	(1, 36, 200)
	MaxPool2D	–	(1, 2)	0	(1, 18, 200)
	Dropout	–	–	0	(1, 18, 200)
	Flatten	–	–	0	(3600)
Classifier	Dense	–	–	7202	(2)
	Activation	–	softmax	0	(2)

Tabla 3.1: Arquitectura DeepConvNet utilizada.

Por otro lado, la arquitectura ShallowConvNet fue diseñada específicamente para la clasificación de características de la potencia de banda. Su estructura busca aproximarse al funcionamiento del método FBCSP mediante operaciones equivalentes implementadas mediante capas convolucionales. Al igual que DeepConvNet, las primeras capas realizan convoluciones temporales y espaciales. Sin embargo, en este caso la convolución temporal utiliza kernels de mayor tamaño con el objetivo de capturar mejor la información frecuencial de la señal.

Después de estas convoluciones, ShallowConvNet incorpora una secuencia de operaciones compuesta por una *no linealidad cuadrática*, una capa de *mean-pooling* y una activación logarítmica. Este conjunto de transformaciones es análogo al cálculo de la varianza logarítmica utilizado tradicionalmente en FBCSP. Además, el uso de múltiples regiones de *pooling* dentro de un mismo ensayo permite a la red aprender variaciones temporales de la potencia de banda a lo largo del tiempo [20].

Block	Layer	# filters	Size	# params	Output
1	Input	–	–	0	(27, 400, 1)
	Conv2D	40	(1, 20)	840	(27, 381, 40)
	Conv2D	40	(27, 1)	43200	(1, 381, 40)
	BatchNorm	–	–	160	(1, 381, 40)
	Activation	–	square	0	(1, 381, 40)
	AveragePool2D	–	(1, 60)	0	(1, 27, 40)
	Activation	–	log	0	(1, 27, 40)
	Dropout	–	$p = 0,4$	0	(1, 27, 40)
	Flatten	–	–	0	(1080)
Classifier	Dense	–	–	2162	(2)
	Activation	–	softmax	0	(2)

Tabla 3.2: Arquitectura ShallowConvNet utilizada.

Las Tablas 3.2 y 3.1 muestran las configuraciones específicas de las arquitecturas ShallowConvNet y DeepConvNet utilizadas en este trabajo. En ambos casos, se adaptaron los parámetros originales propuestos por Schirrmeister et al. [20] para ajustarse a las características del conjunto de datos empleado, compuesto por señales EEG de 27 canales y ventanas temporales de 400 muestras.

Puede observarse que ShallowConvNet está formada por un único bloque convolucional seguido de las operaciones de agrupamiento y clasificación, mientras que DeepConvNet emplea una estructura jerárquica compuesta por cuatro bloques convolucionales sucesivos, incrementando progresivamente el número de filtros y la capacidad de representación del modelo.

Los resultados obtenidos por Schirrmeister et al. mostraron que estas arquitecturas alcanzaban resultados comparables a métodos clásicos como Filter Bank Common Spatial Pattern (FBCSP) [20, 30].

3.4.2. EEGNet

EEGNet es un modelo de red neuronal convolucional (CNN) diseñado específicamente para la clasificación de señales EEG. Su arquitectura se basa en el uso de convoluciones *Depthwise* y *Separable*, ampliamente utilizadas en tareas de clasificación de imágenes, adaptándolas al procesamiento de señales EEG. Este enfoque permite extraer características espaciales y temporales de forma eficiente, utilizando

conceptos como el filtrado espacial y la construcción de bancos de filtros [28].

Las características principales de este modelo son:

- Independencia respecto al paradigma BCI, permitiendo su aplicación en distintos tipos de señales EEG.
- Menor número de parámetros en comparación con otros modelos de CNN.
- Buena capacidad de generalización incluso con conjuntos de datos limitados.
- Arquitectura compacta con técnicas de regularización integradas, como *Batch Normalization* y *Dropout*.

El modelo comienza con una capa convolucional temporal encargada de extraer información frecuencial de la señal EEG. Posteriormente, se aplica una convolución *Depthwise* que aprende filtros espaciales específicos para cada mapa de características. A continuación, la arquitectura utiliza una convolución *Separable*, compuesta por una convolución *Depthwise* seguida de una convolución *Pointwise*. La primera resume temporalmente cada mapa de características de manera independiente, mientras que la segunda combina la información obtenida entre los distintos mapas de características [28]. El esquema de esta arquitectura se muestra en la figura 3.4.

Finalmente, el modelo se entrena utilizando el optimizador Adam y minimizando la función de pérdida de entropía cruzada categórica.

La elección de este modelo se debe principalmente a su arquitectura compacta y a su capacidad para obtener buenos resultados incluso con conjuntos de datos reducidos, una situación habitual en aplicaciones basadas en EEG. Además, el uso de convoluciones *Depthwise* y *Separable* permite reducir significativamente el número de parámetros del modelo respecto a otras arquitecturas convolucionales, disminuyendo así el coste computacional del entrenamiento [28]. Finalmente, esta arquitectura ha mostrado buenos resultados al clasificar potenciales corticales relacionados con el movimiento (MRCP). Estas características hacen de EEGNet una arquitectura adecuada para la clasificación de señales EEG en el contexto de este trabajo.

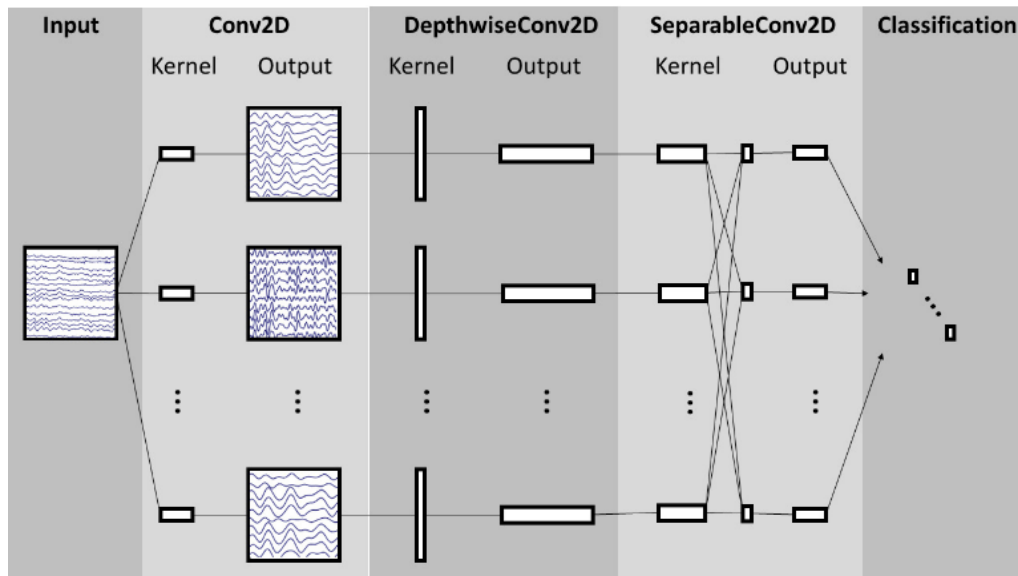


Figura 3.4: Arquitectura de EEGNet. las líneas muestran la conexión entre las capas [28].

3.5. Metodología experimental

Aquí es donde entra todo tu proyecto de verdad.

3.5.1. Variables del estudio

Arquitectura del modelo

Método de entrenamiento:

- same-day
- acumulativo
- fine-tuning

Tarea:

- static
- motion

Usuario

3.5.2. Estrategia de entrenamiento

epochs

batch size

callbacks:

early stopping

reduce LR

función de pérdida

métrica (accuracy)

3.5.3. Evaluación

validación cruzada

pseudo-online

explicar qué significa pseudo-online

3.6. Infraestructura Experimental

sistema para ejecutar múltiples experimentos gestión de parámetros almacenamiento de resultados (DuckDB) automatización

Se ha programado un microframework para el desarrollo de experimentos de Machine Learning.

Como se ha comentado en el apartado 3.4, se ha realizado la comparación de tres modelos de redes neuronales convolucionales para la clasificación de la intención de caminar o detenerse con un exoesqueleto. Se ha utilizado un dataset de EEG con 27 canales, obtenido de una muestra de un estudio previo XXXXXX. Los parametros

a comparar son la arquitectura de la red, el metodo de entrenamiento, la tarea a predecir y la variabilidad entre usuarios.

Al necesitarse de cientos de ejecuciones para obtener todos los datos necesarios, durante las etapas iniciales se tomó la decisión de enfocar el proyecto de manera horizontal, preparando una base de ejecución sobre la cual modificar facilmente todo lo necesario para cada ejecución y permitiendo ejecutar multiples experimentos de manera secuencial.

3.6.1. Diseño de experimentos

combinaciones de parámetros n^o de ejecuciones cómo comparas resultados

4. Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos durante la experimentación se han almacenado en una base de datos DuckDB, tal y como se describió en la Sección 3.6. Las tablas generadas contienen, para cada ejecución realizada, tanto los metadatos asociados al entrenamiento como las métricas obtenidas durante su evaluación.

Con el objetivo de reducir la influencia de posibles valores atípicos (*outliers*) sobre el análisis estadístico, se han creado vistas derivadas de cada tabla en las que se eliminan aquellos registros cuyos valores de *accuracy* se encuentran fuera de un intervalo de tres desviaciones estándar respecto a la media. Este procedimiento, basado en el método *Z-Score* [36], se define como:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

donde x representa el valor analizado, μ la media de la distribución y σ la desviación estándar. De esta forma, se consideran valores atípicos aquellos que cumplen:

$$|z| > 3$$

Además, también se han eliminado aquellos registros correspondientes a entrenamientos incompletos o interrumpidos, con el fin de garantizar la consistencia de los resultados analizados.

Tras aplicar este proceso de filtrado, el número total de registros válidos quedó reducido de la siguiente manera:

- Tabla de entrenamientos: de 1917 registros originales se eliminaron 105, obteniéndose un total de 1812 registros válidos.
- Tabla de trials: de 5751 registros originales se eliminaron 515, obteniéndose un total de 5246 registros válidos.

- Tabla de clases: de 15336 registros originales se eliminaron 3331, obteniéndose un total de 12605 registros válidos.

En esta sección se presentarán estos resultados, los cuales se discutirán y analizarán siguiendo la siguiente metodología:

Primero se analizarán los resultados obtenidos por cada modelo en función de la tarea

4.1. Tarea Estática

4.1.1. Comparación de Global

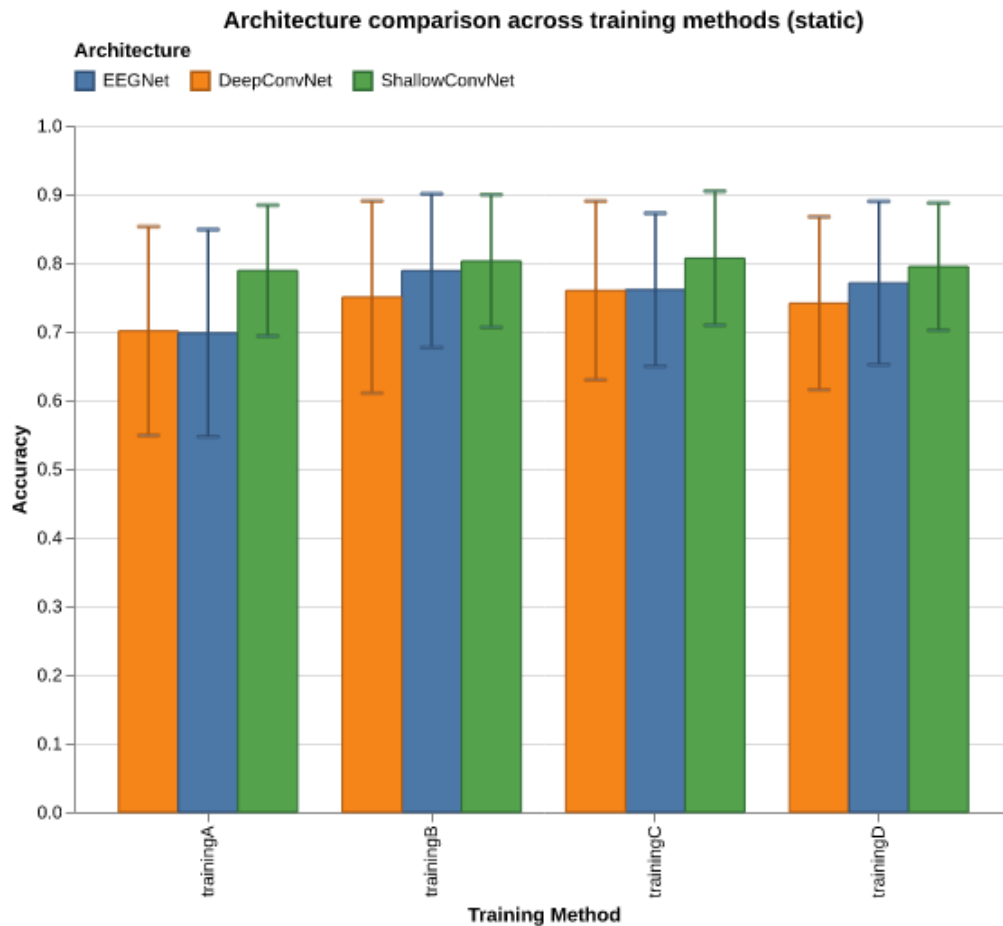


Figura 4.1: Comparación general de las distintas arquitecturas y métodos de entrenamiento en la tarea estática

Me da igual todo, solo me centro en los modelos. hago avg y std con los metodos y los usuarios

4.1.2. Comparación de Método de Entrenamiento

Me da igual todo, solo me centro en los metodos. hago avg y std con los modelos y los usuarios

4.1.3. Variabilidad Entre Usuarios

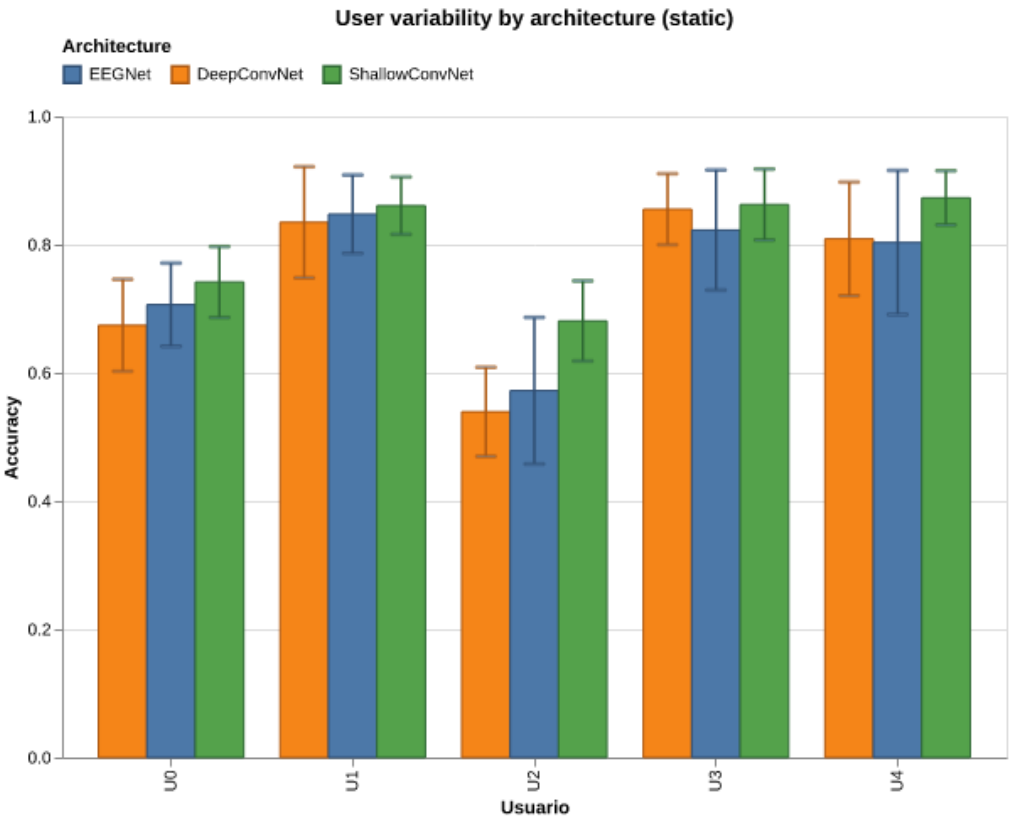


Figura 4.2: Variabilidad entre usuarios en la tarea estática

4.1.4. Mejor Configuración

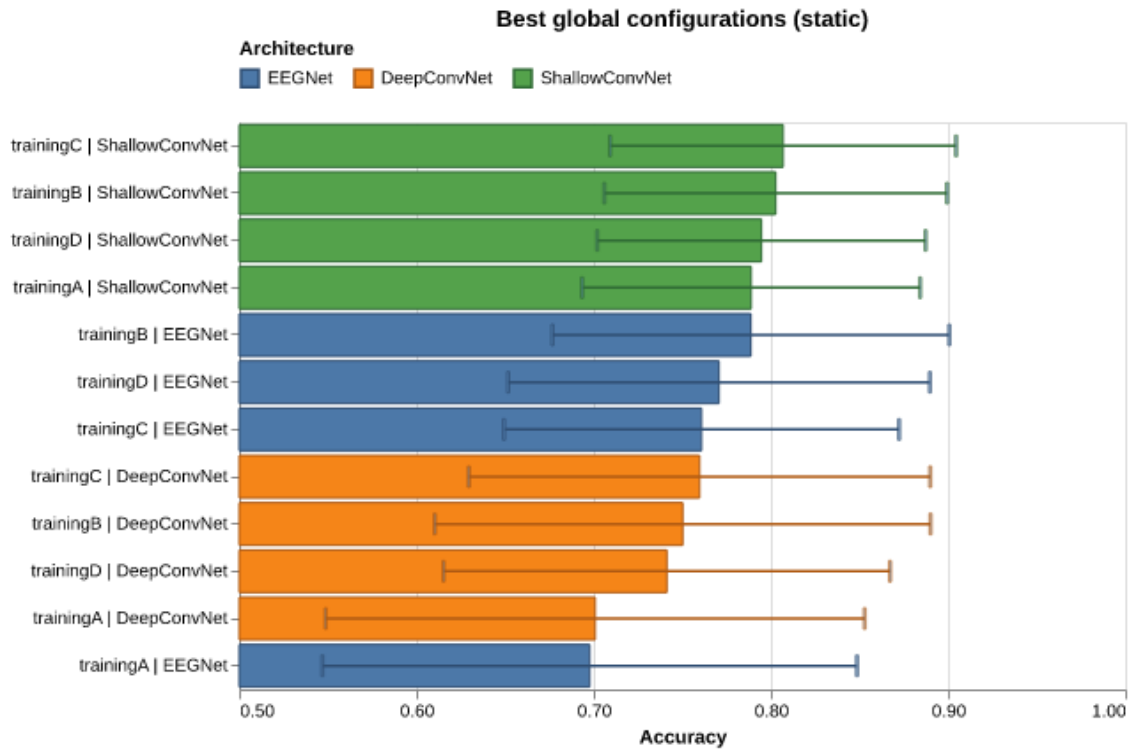


Figura 4.3: Mejores configuraciones globales en la tarea estática

4.2. Tarea Movimiento

mismo esquema

4.2.1. Comparación de Global

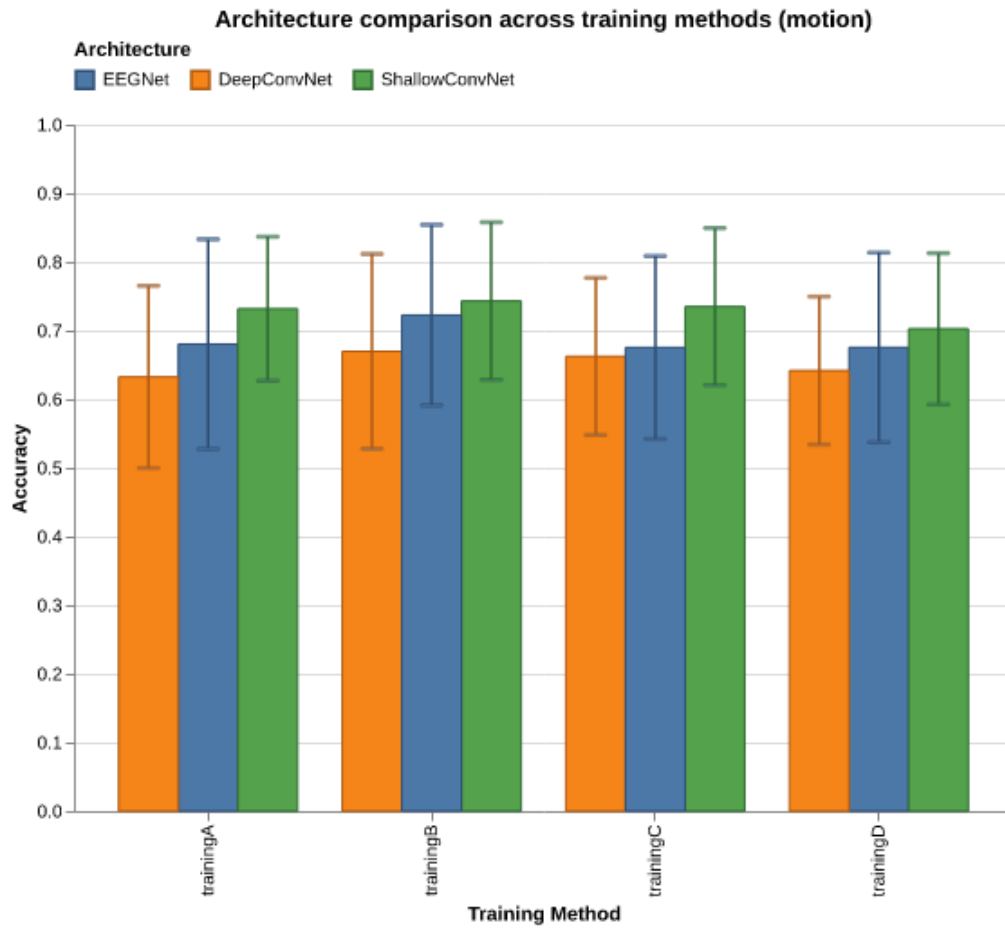


Figura 4.4: Comparación general de las distintas arquitecturas y métodos de entrenamiento en la tarea de movimiento

4.2.2. Comparación de Método de Entrenamiento

4.2.3. Variabilidad Entre Usuarios

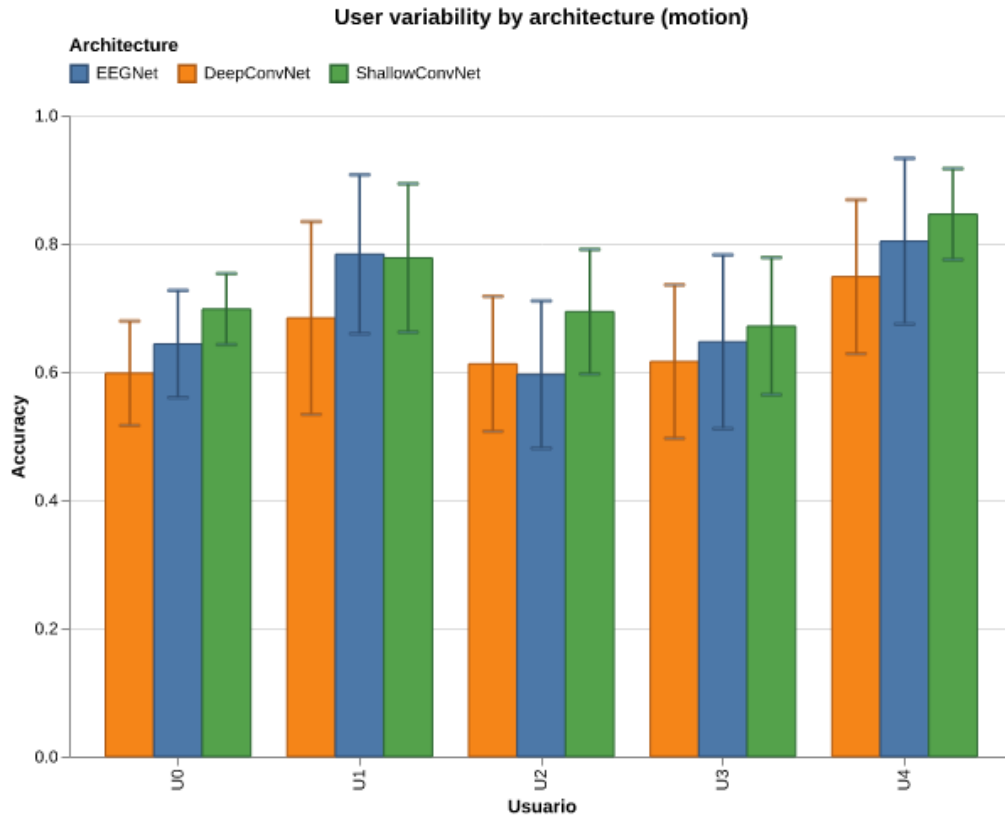


Figura 4.5: Variabilidad entre usuarios en la tarea de movimiento

4.2.4. Mejor Configuración

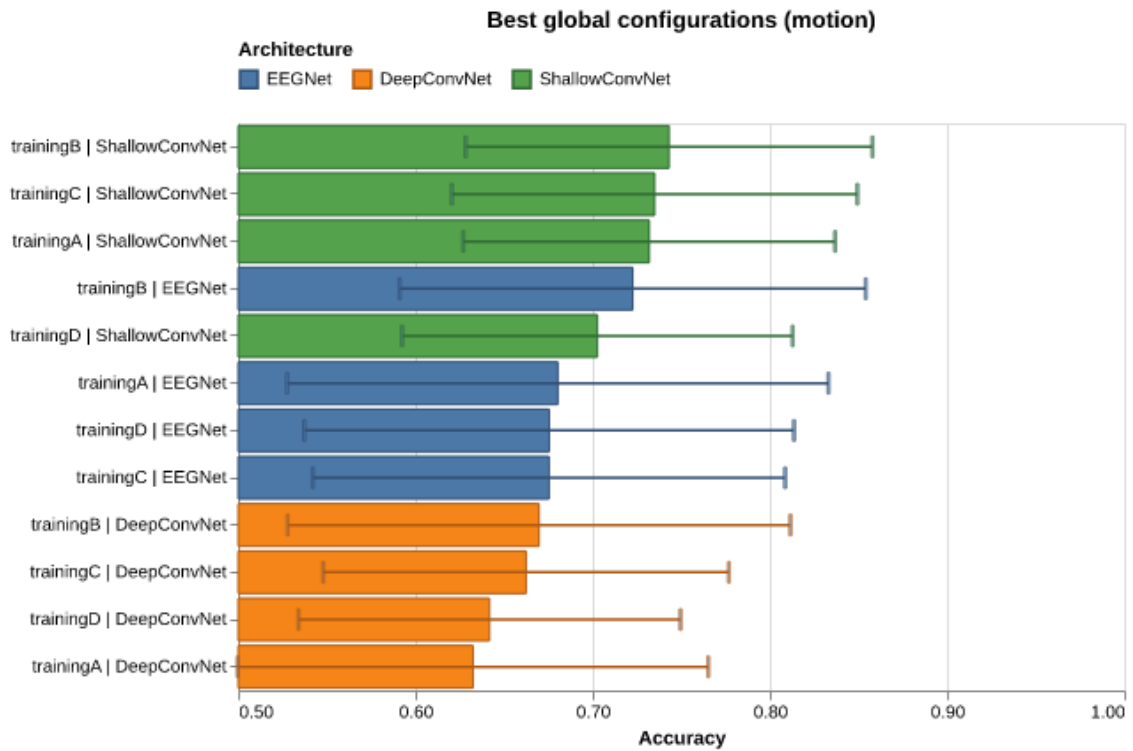


Figura 4.6: Mejores configuraciones globales en la tarea de movimiento

4.3. Comparación entre tareas

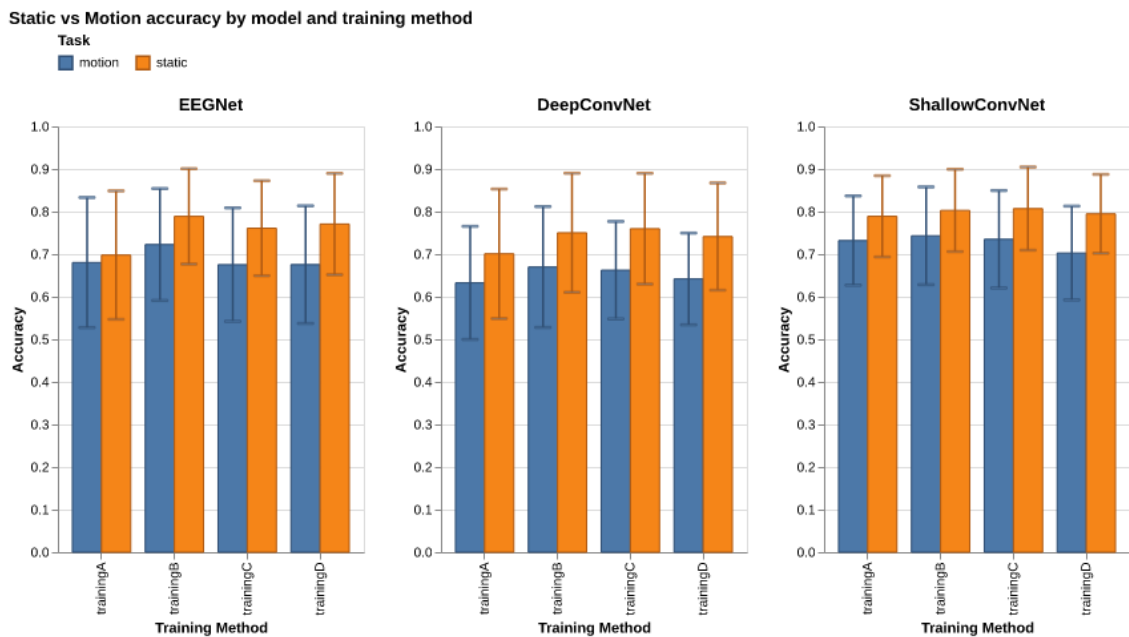


Figura 4.7: Comparación de la precisión entre la tarea estática y la de movimiento

5. Conclusiones

en función de los resultados obtenidos, se expondrán las conclusiones de la investigación y se propondrán trabajos futuros.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] World Health Organization (WHO). *Lesión de la médula espinal*. Organización Mundial de la Salud. 16 de abr. de 2024. URL: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury> (visitado 29-04-2026).
- [2] S. A. Bravo, J. A. Porras y M. J. Á. Urricelqu. «La exclusión social, una problemática estructural entre las personas con discapacidad». En: *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales* 36 (1 de nov. de 2017), págs. 167-181. ISSN: 1989-6190. URL: <https://revistas.um.es/areas/article/view/308211> (visitado 29-04-2026).
- [3] G. Morone y R. S. Calabrò. «Neurorehabilitation Insights in 2024: Where Neuroscience Meets Next-Gen Tech». En: *Brain Sciences* 15.10 (25 de sep. de 2025), pág. 1043. ISSN: 2076-3425. DOI: 10.3390/brainsci15101043. PMID: 41154139. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12562376/> (visitado 04-05-2026).
- [4] M. T. Sadiq, M. Z. Aziz, A. Almogren, A. Yousaf, S. Siuly y A. U. Rehman. «Exploiting Pretrained CNN Models for the Development of an EEG-based Robust BCI Framework». En: *Computers in Biology and Medicine* 143 (1 de abr. de 2022), pág. 105242. ISSN: 0010-4825. DOI: 10.1016/j.combiomed.2022.105242. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482522000348> (visitado 27-04-2026).
- [5] S. Yun. «Advances, Challenges, and Prospects of Electroencephalography-Based Biomarkers for Psychiatric Disorders: A Narrative Review». En: *Journal of Yeungnam Medical Science* 41.4 (9 de sep. de 2024), págs. 261-268. ISSN: 2799-8010. DOI: 10.12701/jyms.2024.00668. PMID: 39246060. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11534409/> (visitado 06-05-2026).

- [6] M. C. Emos y S. Agarwal. «Neuroanatomy, Upper Motor Neuron Lesion». En: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2026. PMID: 30725990. URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537305/> (visitado 12-05-2026).

- [7] K. Margetis, J. M. Das y P. D. Emmady. «Spinal Cord Injuries». En: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2026. PMID: 32809556. URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560721/> (visitado 12-05-2026).

- [8] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. *Spinal Cord Injury — National Institute of Neurological Disorders and Stroke*. URL: <https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/spinal-cord-injury> (visitado 12-05-2026).

- [9] I. Corral López, M. Morales Castillo y M. O. González Oria. *Traumatismo medular*. Manuales Clínicos. 2 de nov. de 2023. URL: <https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/urgencias-de-traumatologia/patologia-de-cabeza-y-tronco/traumatismo-medular/> (visitado 12-05-2026).

- [10] S. J. Murphy y D. J. Werring. «Stroke: Causes and Clinical Features». En: *Medicine (Abingdon, England : UK Ed.)* 48.9 (sep. de 2020), págs. 561-566. ISSN: 1357-3039. DOI: 10.1016/j.mpmed.2020.06.002. PMID: 32837228. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7409792/> (visitado 12-05-2026).

- [11] Z. Gao, Z. Pang, Y. Chen, G. Lei, S. Zhu, G. Li, Y. Shen y W. Xu. «Restoring After Central Nervous System Injuries: Neural Mechanisms and Translational Applications of Motor Recovery». En: *Neuroscience Bulletin* 38.12 (1 de dic. de 2022), págs. 1569-1587. ISSN: 1995-8218. DOI: 10.1007/s12264-022-00959-x. URL: <https://doi.org/10.1007/s12264-022-00959-x> (visitado 12-05-2026).

- [12] M. Puderbaugh y P. D. Emmady. «Neuroplasticity». En: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2026. PMID: 32491743. URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557811/> (visitado 13-05-2026).
- [13] R. Di Palma, L. Falco, A. Coccia, F. Amitrano, G. Pagano y G. D'Addio. «Frontiers in Neuro-Rehabilitation: Neural Basis of Cognitive Contributions to Movement across Neurological Populations». En: *Frontiers in Neurology* 16 (4 de jul. de 2025). ISSN: 1664-2295. DOI: 10.3389/fneur.2025.1638254. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2025.1638254/full> (visitado 13-05-2026).
- [14] S. J. Luck. *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. 2.^a ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 30 de mayo de 2014. 416 págs. ISBN: 978-0-262-52585-5.
- [15] D. L. Sherman y N. V. Thakor. «EEG Signal Processing: Theory and Applications». En: *Neural Engineering*. Ed. por B. He. Cham: Springer International Publishing, 2020, págs. 97-129. ISBN: 978-3-030-43395-6. DOI: 10.1007/978-3-030-43395-6_3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-43395-6_3 (visitado 06-05-2026).
- [16] B. Jiang, X. Wang, D. He, S. Cheng, M. Liao, D. Miao, Q. Xia, Y. Zhao y G. Li. «A Comprehensive Review of Deep Learning for Motor Imagery EEG: From Healthy Subjects to Patients». En: *Biomedical Signal Processing and Control* 117 (15 de mayo de 2026), pág. 109680. ISSN: 1746-8094. DOI: 10.1016/j.bspc.2026.109680. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S174680942600234X> (visitado 05-05-2026).
- [17] M. Roohi-Azizi, L. Azimi, S. Heysieattalab y M. Aamidfar. «Changes of the Brain's Bioelectrical Activity in Cognition, Consciousness, and Some Mental Disorders». En: *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran* 31 (3 de sep. de 2017), pág. 53. ISSN: 1016-1430. DOI: 10.14196/mjiri.31.53. PMID:

29445682. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5804435/> (visitado 06-05-2026).

- [18] A. Craik, Y. He y J. L. Contreras-Vidal. «Deep Learning for Electroencephalogram (EEG) Classification Tasks: A Review». En: *Journal of Neural Engineering* 16.3 (abr. de 2019), pág. 031001. ISSN: 1741-2552. DOI: 10.1088/1741-2552/ab0ab5. URL: <https://doi.org/10.1088/1741-2552/ab0ab5> (visitado 27-04-2026).
- [19] A. Telpaz, R. Webb y D. Levy. «Using EEG to Predict Consumers' Future Choices». En: *Journal of Marketing Research* (1 de ago. de 2015). DOI: 10.1509/jmr.13.0564.
- [20] R. T. Schirrmeister, J. T. Springenberg, L. D. J. Fiederer, M. Glasstetter, K. Eggensperger, M. Tangermann, F. Hutter, W. Burgard y T. Ball. «Deep Learning with Convolutional Neural Networks for EEG Decoding and Visualization». En: *Human Brain Mapping* 38.11 (2017), págs. 5391-5420. ISSN: 1097-0193. DOI: 10.1002/hbm.23730. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hbm.23730> (visitado 09-03-2026).
- [21] L. S. Vidyaratne y K. M. Iftexharuddin. «Real-Time Epileptic Seizure Detection Using EEG». En: *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering* 25.11 (nov. de 2017), págs. 2146-2156. ISSN: 1558-0210. DOI: 10.1109/TNSRE.2017.2697920. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7911296> (visitado 06-05-2026).
- [22] S. Saha y M. Baumert. «Intra- and Inter-subject Variability in EEG-Based Sensorimotor Brain Computer Interface: A Review». En: *Frontiers in Computational Neuroscience* 13 (21 de ene. de 2020), pág. 87. ISSN: 1662-5188. DOI: 10.3389/fncom.2019.00087. PMID: 32038208. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6985367/> (visitado 06-05-2026).

- [23] M. J. Young, D. J. Lin y L. R. Hochberg. «Brain-Computer Interfaces in Neurorecovery and Neurorehabilitation». En: *Seminars in neurology* 41.2 (abr. de 2021), págs. 206-216. ISSN: 0271-8235. DOI: 10.1055/s-0041-1725137. PMID: 33742433. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8768507/> (visitado 10-05-2026).
- [24] B. He, H. Yuan, J. Meng y S. Gao. «Brain-Computer Interfaces». En: *Neural Engineering*. Ed. por B. He. Cham: Springer International Publishing, 2020, págs. 131-183. ISBN: 978-3-030-43395-6. DOI: 10.1007/978-3-030-43395-6_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-43395-6_4 (visitado 06-05-2026).
- [25] S. Waldert. «Invasive vs. Non-Invasive Neuronal Signals for Brain-Machine Interfaces: Will One Prevail?» En: *Frontiers in Neuroscience* 10 (27 de jun. de 2016). ISSN: 1662-453X. DOI: 10.3389/fnins.2016.00295. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2016.00295/full> (visitado 01-06-2026).
- [26] J. R. Wolpaw y E. W. Wolpaw. *Brain-Computer Interfaces: Principles and Practice*. New York: Oxford University Press, 2012. ISBN: 978-0-19-993268-9.
- [27] J. R. Wolpaw, N. Birbaumer, D. J. McFarland, G. Pfurtscheller y T. M. Vaughan. «Brain-Computer Interfaces for Communication and Control». En: *Clinical Neurophysiology* 113.6 (1 de jun. de 2002), págs. 767-791. ISSN: 1388-2457. DOI: 10.1016/S1388-2457(02)00057-3. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245702000573> (visitado 01-06-2026).
- [28] V. J. Lawhern, A. J. Solon, N. R. Waytowich, S. M. Gordon, C. P. Hung y B. J. Lance. «EEGNet: A Compact Convolutional Network for EEG-based Brain-Computer Interfaces». En: *Journal of Neural Engineering* 15.5 (1 de oct. de 2018), pág. 056013. ISSN: 1741-2560, 1741-2552. DOI: 10.1088/1741-2552/

aace8c. arXiv: 1611.08024 [cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/1611.08024> (visitado 25-04-2025).

- [29] J. M. Azorín Poveda y E. Iañez Martínez. *Tema 3.2. Interfaces cerebrales basadas en señales EEG - parte 3*. Master's course notes. Universidad Miguel Hernández de Elche, 2024-2025, pág. 20. URL: https://campus.umh.es/pluginfile.php/872170/mod_resource/content/2/Tema%203.2.%20Interfaces%20cerebrales%20basadas%20en%20sen%CC%83ales%20EEG%20-%20parte%203.pdf.
- [30] B. J. Edelman, S. Zhang, G. Schalk, P. Brunner, G. Müller-Putz, C. Guan y B. He. «Non-Invasive Brain-Computer Interfaces: State of the Art and Trends». En: *IEEE Reviews in Biomedical Engineering* 18 (2025), págs. 26-49. ISSN: 1941-1189. DOI: 10.1109/RBME.2024.3449790. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10646518/references> (visitado 25-05-2026).
- [31] C. M. Köllöd, A. Adolf, G. Márton e I. Ulbert. «Deep Comparisons of Neural Networks from the EEGNet Family». En: *Electronics* 12.12 (20 de jun. de 2023), pág. 2743. ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics12122743. arXiv: 2302.08797 [eess.SP]. URL: <http://arxiv.org/abs/2302.08797> (visitado 19-05-2026).
- [32] *Introduction to Altair in Python*. GeeksforGeeks. 19 de jul. de 2025. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/python/introduction-to-altair-in-python/> (visitado 07-04-2026).
- [33] *Why DuckDB*. DuckDB. 2026. URL: https://duckdb.org/why_duckdb.html (visitado 07-04-2026).
- [34] L. Ferrero, V. Quiles, M. Ortiz, E. Ianez y J. M. Azorin. «BCI Based on Lower-Limb Motor Imagery and a State Machine for Walking on a Treadmill». En: *2021 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural En-*

- gineering (NER)*. 2021 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER). Italy: IEEE, 4 de mayo de 2021, págs. 1-4. ISBN: 978-1-7281-4337-8. DOI: 10.1109/NER49283.2021.9441216. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9441216/> (visitado 29-08-2025).
- [35] M. Mirnaziri, M. Rahimi, S. Alavikakhaki y R. Ebrahimpour. «Using Combination of μ ,B and Y Bands in Classification of EEG Signals». En: *Basic and Clinical Neuroscience* 4.1 (2013), págs. 76-87. ISSN: 2008-126X. PMID: 25337331. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4202559/> (visitado 21-05-2026).
- [36] P. Venkataanusha, C. Anuradha, D. Murty y S. Chebrolu. «Detecting Outliers in High Dimensional Data Sets Using Z-Score Methodology». En: *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering* 9 (30 de nov. de 2019), págs. 48-53. DOI: 10.35940/ijitee.A3910.119119.

ANEXOS

tantos como se considere necesario en función de los aspectos concretos que se quieran especificar.

A. Primer anexo

Contenido del primer anexo (texto, tablas, figuras, códigos, etc.)

B. Segundo anexo

Contenido del segundo anexo (texto, tablas, figuras, códigos, etc.)

interwordspace: 3.91663pt

interwordstretch: 1.95831pt

emergencystretch: 35.24963pt